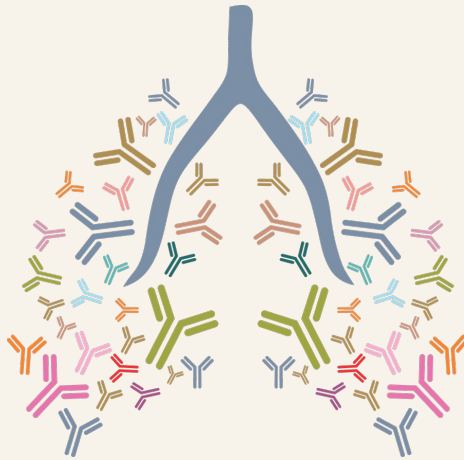




GUIA ILUSTRADO PARA PAIS

Tosse na Infância

O que é normal, quando se preocupar
e o que realmente ajuda

Dra. Ana Karina Fernandes

Pneumologista Pediátrica

CRM/RN 5751 • RQE 6271

PARA COMEÇAR

A tosse é uma defesa, não uma doença



A tosse protege as vias respiratórias do seu filho: ela expulsa secreções, poeira, micro-organismos e pequenos objetos que possam ter entrado por engano.

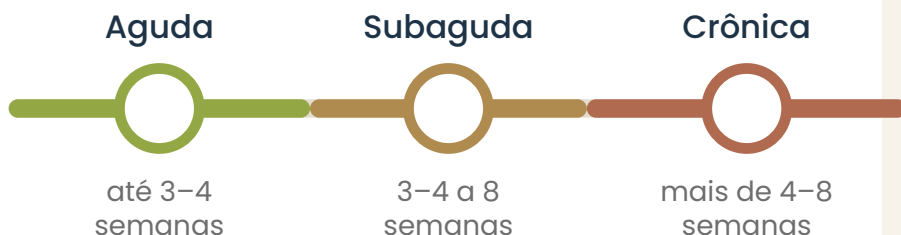
Por isso, na maioria das vezes ela é **esperada, útil e passa sozinha** — sem precisar de nenhum remédio específico.

Você sabia?

- ✓ Uma criança saudável tosse, em média, **até 11 vezes por dia**.
- ✓ Quem frequenta creche ou escola pode ter de **8 a 12 infecções respiratórias por ano** — e cada uma delas pode causar tosse.

Quanto tempo a tosse costuma durar?

Observar **há quantos dias** a tosse começou é a informação mais útil que você pode levar para a consulta. É ela que orienta o próximo passo.



Importante: um simples resfriado costuma causar tosse por cerca de **10 dias**, mas em muitas crianças ela pode durar **3 a 4 semanas** até sumir de vez. Isso, sozinho, não significa que exista algo grave.

O que merece atenção não é apenas a duração isolada, mas a **tosse que piora em vez de melhorar**, que se repete com frequência ao longo dos meses ou que vem acompanhada dos sinais das próximas páginas.

Os tipos de tosse

Nenhum som fecha um diagnóstico sozinho, mas descrever a tosse ajuda muito o pediatra.



Tosse seca

Sem secreção. Comum no início de viroses, em alergias e diante de irritantes como fumaça e poeira.



Tosse com secreção

Som “carregado”, de peito cheio. Indica muco nas vias aéreas.



Tosse “de cachorro”

Rouca e alta, típica da laringite (crupe). Costuma piorar à noite.



Tosse em crises com guincho

Acessos seguidos de um som agudo ao puxar o ar. Precisa de avaliação.

Tosse que piora à noite ou com corrida e brincadeira pode sugerir asma, refluxo ou escorrimento de secreção pelo nariz – vale comentar na consulta.

Sinais de alarme



Se a criança apresentar **qualquer um** dos sinais abaixo, procure atendimento de urgência sem esperar.

- Dificuldade para respirar: respiração rápida, afundamento entre as costelas, gemido ou batimento das asas do nariz
- Lábios, língua ou rosto arroxeados
- Criança muito prostrada, difícil de acordar
- Recusa de líquidos ou sinais de desidratação
- Febre alta por mais de 3 dias, ou que volta depois de já ter passado
- Tosse com sangue
- Engasgo súbito com alimento ou objeto pequeno
- Bebê com menos de 3 meses com tosse e febre

Diante de qualquer um desses sinais, **não espere para ver se melhora sozinho** e não tente medicar em casa: leve a criança para avaliação presencial.

Na dúvida, procure avaliação. A percepção de quem cuida todos os dias é um dado clínico valioso.

SEM PRESSA, MAS SEM ADIAR

Quando marcar uma consulta



Nem toda tosse preocupante é uma emergência. Estas situações pedem avaliação **com o pediatra que acompanha a criança**:

- ✓ A tosse passou de **3 a 4 semanas**, mesmo sem sinais de gravidade
- ✓ Os episódios se **repetem com frequência** ao longo dos meses
- ✓ O quadro está **piorando** em vez de melhorar aos poucos
- ✓ A tosse atrapalha o **sono, a alimentação** ou as atividades da criança
- ✓ Há **histórico familiar** de asma ou alergias e a tosse não passa
- ✓ Você sente que **algo não está bem** com seu filho

Leve anotado: há quantos dias começou, como é a tosse, se há febre, se piora à noite, o que já foi usado e se alguém em casa está doente. Isso encurta o caminho até o diagnóstico.

COM RESPALDO CIENTÍFICO

O que realmente ajuda

Medidas simples, seguras e apoiadas por estudos:



Mel puro

Só a partir de **1 ano**. Estudos mostram que pode reduzir a tosse noturna e melhorar o sono da família.



Soro fisiológico no nariz

Alivia a obstrução nasal e o escorrimento de secreção, que alimentam a tosse.



Bastante líquido

Água, leite materno ou fórmula, conforme a idade. Medida simples de conforto e suporte.

Nunca ofereça mel a bebês com menos de 1 ano — existe risco de botulismo infantil, uma doença grave. Entre 1 e 2 anos, use com moderação.

Complete com: ambiente **livre de fumaça de cigarro**, vacinas em dia e lavagem frequente das mãos.

EVITE SEM ORIENTAÇÃO

O que não ajuda



Revisões científicas avaliaram os produtos mais usados contra a tosse infantil. O resultado surpreende muitos pais:



Xaropes para tosse

Antitussígenos como dextrometorfano e codeína não se mostraram melhores que placebo em crianças e trazem risco de efeitos adversos.



Anti-histamínicos e descongestionantes

Sem benefício comprovado para tosse e resfriado em menores de 5 anos.



Expectorantes e mucolíticos

Eficácia e segurança não comprovadas em estudos pediátricos de qualidade.



Antibióticos por conta própria

Não agem contra vírus — a causa da grande maioria das tosse.



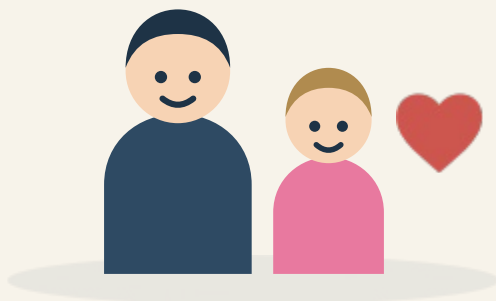
Aspirina (AAS)

Contraindicada em crianças com viroses, pelo risco de síndrome de Reye.

Remédios existem e são necessários quando há uma causa que os justifique — quem define isso é o médico, após examinar a criança.

Resumo em seis lembretes

- ✓ Tosse costuma ser **defesa**, não doença.
- ✓ Anote **há quantos dias** começou.
- ✓ Até 3-4 semanas, geralmente é viral.
- ✓ Fique atento aos **sinais de alarme**.
- ✓ Mel só **depois de 1 ano** de idade.
- ✓ Xarope de tosse: **não** sem indicação.



Na dúvida, converse com o pediatra
que acompanha o seu filho.



Dra. Ana Karina Fernandes

Pneumologista Pediátrica

CRM/RN 5751

RQE 6271

Este material tem finalidade **educativa** e não substitui a consulta médica, o diagnóstico ou o tratamento indicado para o seu filho.

Conteúdo baseado em orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria, revisões Cochrane e diretrizes brasileiras de manejo da tosse.